Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Fernando Enrique Muñoz Villalobos				Sexo	F		M	X
Fecha Nacimiento	21-11-2014	Edad actual		años	meses	País natal:			
Domicilio actual:	B. los Deudores, Ernesto Iglesia Font				Teléfono	963082854 (padre) 985756700 (madre)			
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☐						
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☑ habla ☑ lee ☑ escribe ☑						
Escolaridad actual:	Texto básico A	Establecimiento	Ciclo mixto, Básico nº 2						

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 30/04/26	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Ruth Villalobos Rojo	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista:	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Paula Collio Rubilar	Nombre:
Rol/cargo: Psicopedagoga	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Estudiante con Condición Espectro Autista.
TDA - H

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí **(especificar)**

Pediatría:	Psicología: Existe particular (2 veces al mes)
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología:	Terapia Ocupacional: Existe Particular
Neurología:	Otro: TDA - H

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☑ cesárea (señalar motivo) Cordón en cuello

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☒ SI ☐ NO	Peso: 3,250	Talla: 49 cm.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Sí	~~No~~	Traumatismos	Sí	~~No~~	Encefalitis	Sí	~~No~~
Obesidad	~~Sí~~	No	Intoxicación	Sí	~~No~~	Meningitis	Sí	~~No~~
Fiebre alta	Sí	~~No~~	Enfermedad respiratoria	Sí	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	Sí	~~No~~	Asma	Sí	~~No~~			
Hospitalizaciones	Sí	No	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud	~~Sí~~	No	Vacunas	~~Sí~~	No

Observaciones:

Sin observaciones

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 6 m aprox	Se sienta sólo/a: 9 meses	Camina sin apoyo: 11 meses.
Primeras palabras: Antes del año	Primeras frases: Después del año	Se viste solo/a: 6 años
Controla esfínter vesical Diurno: ~~✓~~ Nocturno: después de los 2 años	Controla esfínter anal Diurno: ✓ Nocturno: después de los dos años	

Observaciones:

En su actividad motora general se aprecia:
☒ normal ☐ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:
☒ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Sí~~	No	Caídas frecuentes	Sí	~~No~~	Dominancia lateral derecho	~~Sí~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Sí~~	No	Prensión	~~Sí~~	No	Pinza	~~Sí~~	No
Ensarta	~~Sí~~	No	Dibuja	~~Sí~~	No	Escribe	~~Sí~~	No

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Sí~~	No	Manipula y Explora objetos no tanto	Sí	No
Demanda objetos y compañía	~~Sí~~	No	Comprende prohibiciones	~~Sí~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Sí~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

Observaciones: cuando se emociona habla (aletea)

Sin observaciones

5.3. Visión - Audición:

Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.) al mover	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	~~Sí~~	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos en general	~~Sí~~	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	~~Sí~~	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	~~Sí~~	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	~~Sí~~	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	~~Sí~~	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	~~No~~
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	~~Sí~~	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos cuando el ruido es fuerte	~~Sí~~	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	~~No~~	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	~~No~~
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	~~No~~	La pronunciación oral es adecuada le cuesta modular	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	~~Sí~~	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	~~No~~

Observaciones: Usuario de lentes

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.4. Desarrollo del Lenguaje

El niño (a) se comunica preferentemente en forma

☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):

Características del lenguaje expresivo

Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	~~No~~	Emite/produce frases	~~Sí~~	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	~~No~~	Relata experiencias	~~Sí~~	No
Emite palabras/produce señas	~~Sí~~	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No

Características del lenguaje comprensivo le cuesta modular

Identifica objetos	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones simples	~~Sí~~	No
Identifica personas	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	~~No~~
Comprende conceptos abstractos	~~Sí~~	No	Sigue instrucciones grupales le cuesta	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos a veces hay que explicar	Sí	No

Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos):

no.

Observaciones:

Sin observaciones.

5.5. Desarrollo Social

Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	~~No~~	Se relaciona en forma colaborativa Con personas que conoce	~~Sí~~	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	~~No~~	Respeta normas sociales	~~Sí~~	No
Participa en actividades grupales	Sí	~~No~~	Respeta normas escolares	~~Sí~~	No
Opta por trabajo individual	~~Sí~~	No	Muestra sentido del humor	~~Sí~~	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	~~No~~	Movimientos estereotipados	~~Sí~~	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	~~Sí~~	No	Pataletas frecuentes De descriguto ultimamente	Sí	No

Ante los siguientes estímulos su reacción es:

Luces:	**Sonidos:**	**Personas extrañas:**
☐ natural ☑ desmesurada	☐ natural ☑ desmesurada	☑ natural ☐ desmesurada

Observaciones:

retraido o tmido.

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	~~Sí~~	No	Trastorno motor	Sí	~~No~~
Epilepsia	Sí	~~No~~	Problema bronco-respiratorio	Sí	~~No~~
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	Sí	~~No~~
Pérdida auditiva	Sí	~~No~~	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	Sí	~~No~~	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Recibe terapia ocupacional y psicologia desde Nov. año pasado.

Alimentación: ☐ normal ☐ "malo/a" para comer ☑ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☑ inquieto Horas que duerme: 6 horas.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☐ despierta de buen humor normal

Duerme: ☑ solo ☐ acompañado
(Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☑ alegre ☐ juguetón/bromista ☐ risueño(a) ☑ triste ☐ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)

Otro:

Observaciones:

Consume melatonina para el sueño

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.				
Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Ruth Villalobos	Madre	41	U. incompleto	Administrativo
2. Eduardo Muñoz	Padre	40	U. completo	Informatico
3. Mª Paz Muñoz	Hermano	6	1º Básico	escolar.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia
(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):
Padre con condición espectro Autista 2 primos con Condición espectro Autista Antecedentes Cancer. hipotiroidismo.
Observaciones:

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar					
Edad de ingreso al sistema escolar	9 m	Asistió a jardín infantil		✓ Sí	No
Nº de colegios en que ha estudiado	5	Modalidad de enseñanza Regular ☑ Especial ☐ Técnica ☐:			
Motivo de los cambios: Por cambios de domicilio					
Ha repetido curso/s	Sí	✓ No	Curso(s)	Motivo: No repitente	

Situación actual											
Nivel/curso actual	6º		**Dificultad de aprendizaje**	✓ Sí	No	**Dificultad para participar**	✓ Sí	No	**Conducta disruptiva**	Sí	✓ No
Asiste regularmente	✓ Sí	No	Asiste con agrado	a veces Sí	No	Apoyo familiar en tareas	✓ Sí	No	Amigos (as)	✓ Sí	No

Actitud de la familia
¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante? ☑ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....
¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante? ☑ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐compasión ☐ tensión ☐ otra .....
¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante? ☑ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra ..... Especifique el tipo de refuerzos o premios: ☑ expresiones afectivas ☐ alimentos preferidos ☐ ver TV ☐ juguetes ☑ tiempo libre ☐ otro(s).....
¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante? ☑ madre ☑ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares ☐ Otros profesionales .....
¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante? ☑ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)
¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje? Sí

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

☐ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Niño pasado sufrió acoso escolar por este motivo su autoestima bajo y no quería hacer ir al liceo.
La familia asiste a evaluación en psicologo y se deriva al neurologo en mayo de este niño es diagnosticado con TEA.
Sin otra red de apoyo solo padres dentro la ciudad.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY